

以药物相互作用为切入点开展临床药学服务

周晨

杭州市第二人民医院/杭州师范大学附属医院 (浙江杭州 310000)

摘要:目前临床上存在的主要问题为临床药师工作尚未有成熟模式,因此临床药师在开展日常临床药学服务工作时需深入临床一线,全程参与用药过程,而选取合理的切入点十分重要。药物间相互作用会对药物的作用效果产生影响,一方面药物作用过度会引起毒性反应增加,另一方面药物作用减弱会引起治疗无效或失败。文章拟从以药物相互作用作为切入点实施临床药学护理服务,现就几年的相关研究进行综述。

关键词:临床药学;药物相互作用;切入点;服务体会

中图分类号:R95

文献标识码:A

DOI:10.16690/j.cnki.1007-9203.2018.05.038

药物间相互作用会对药物的作用效果产生影响,一方面药物作用过度会引起毒性反应增加,另一方面药物作用减弱会引起治疗无效或失败^[1]。对于医院某些特殊科室如神经内科、呼吸内科、心血管内科及重症监护病房而言,由于患者多为老年患者,常并发多种疾病,需要服用两种及以上药物。然而老年患者其机体功能基本消退,机体对药物处理能力降低,药物之间相互作用引发的毒性反应更易出现,因此如何在日常临床药学服务工作中以药物相互作用为切入点开展药学服务是临床药师需考虑和亟待解决的问题。

1 临床药师基本工作方法

1.1 掌握必要的医学理论知识,养成良好的临床思维

临床思维是指医护人员在进行医疗服务时,重视对患者实施相应病症诊治,及关注治疗方案的治疗效果的医疗思维,药学思维则是在为患者选择治疗药物时,重视药物本身的特性,特别是药物的药理学、药动学特性,易引起的不良反应及与其他药物的相互作用的一种思维。临床思维和药学思维最为本质的区别在于临床思维重点关注患者治疗期间的各种反应,将临床指标来评价药物治疗疗效,而药物思维则重点关注用药的完美性和精确性,然而存在与临床指标和临床症状相结合较少的现象^[2]。所以作为医院一名专职临床药师需跳出常规药学思维模式,在熟悉临床知识基础上形成联合患者实际合理选取用药的思维模式。在日常药学服务过程中,临床药师需要与临床医生共同查房,通过查房,学习临床医生的诊治方法,了解相关必要医学检验的作用和意义,熟悉各科室常见疾病的治疗方法,再根据患者的具体情况,通过研究病历和临床医生的治疗方

案,提高医生与患者的沟通有效率,及时了解患者对治疗和使用药物的要求和困惑,并向患者解释治疗的目的是和方案,有效、全面地对患者病情进行评估,及时发现潜在不良反应或并发症等的可能性,对提高临床疗效有着积极的意义^[3]。

1.2 掌握药学基础和专业技能,灵活利用药物相关知识

对于神经内科、呼吸内科、心血管内科及重症监护病房而言,由于其患者多为老年患者,常并发多种基础疾病,这使得临床联合用药已成为各个科室常见的治疗方案,但药物之间的不良相互作用也是临床医护人员需要特别关注的问题。但由于每个医生和护理人员的专科的局限性,虽然了解药物的适应证和使用方法,但对药物的药理学、药动学、药代学等专业知识并不十分了解,容易忽略药物之间的作用。临床药师配合临床诊治,可以有效避免此类现象的发生。因此,这要求临床药师不但要掌握药物本身的相关特性和适应证等,还需认真研究药物之间的相互作用,形成较为系统的药物相互作用定义、分类、使用方法等体系。在日常药学服务工作中,临床药师应针对性了解患者具体病情及检验结果,密切注意药物潜在的相互作用,从而及时发现可能存在的问题^[4]。

1.3 以合理用药监测软件作为依托及时发现可能存在的药物相互作用

配合使用相关的合理用药检测软件,可以增加发现药物之间不良相互作用的可能性。其中,“合理用药系统(PASS)”是一款四川美康医药软件公司研发的一款服务于临床医务工作者,用于查询药物特性信息、咨询合理用药的医学软件,总结和分析药物之间相互作用是该软件的核心功能之一。因此医院

医务工作人员可凭借 PASS 系统对各个病区患者医嘱情况进行初步审核,分析判断可能存在的药物相互作用,若有临床干预意义则立即予以临床医生进行沟通和交流,并调整给药方案^[5]。

2 临床药师对可能存在的药物相互作用处理情况分析

一般而言,药物的相互作用分为药剂学、药动学、药效学三个部分。临床药师的工作是需要将三种相互作用理清,合理利用药物的特性,从种类繁杂的联合用药中发现不良相互作用的可能。以下分别介绍 3 类药物之间的相互作用。

2.1 药物在药效学方面的相互作用

如某位老年男性患者由于左侧人工全髋关节重建手术后出现肺部感染,因病情需要在床旁实施纤维支气管镜,显示右肺中叶存在活动性出血,遂予以雾化吸入垂体后叶素联合其他止血类药物,临床药师在查看医嘱后发现,患者在早前因肾前性肾功能不全静滴前列地尔,而前列地尔能引起血管扩张,抑制血小板聚集,考虑患者肾功能已经得到改善,且右叶肺中叶内侧段发生活动性出血,临床药师建议管床医生停止使用前列地尔,经交流和沟通后管床医生接受建议。

2.2 药物在药动学方面的相互作用

2010 年,我院收治 1 例男性患者,年龄 61 岁,实施主动脉瓣和二尖瓣置换术,在术后持续服用华法林并配合定期对患者凝血功能进行检测。2015 年再次入院,注意期间使用奥美拉唑和头孢哌酮舒巴坦,某日患者在行股静脉置管时出现渗血,临床药师即刻联想到质子泵抑制剂奥美拉唑属于肝药酶抑制剂,同时华法林钠也需经过肝脏细胞色素 P450 代谢,联合使用后会造成功能华法林半衰期延长,临床作用增加。此外头孢哌酮含有硫甲基四氮唑基团,经代谢后能消耗维生素 K,而且头孢哌酮主要经胆道排泄,在胆汁中含量较高,能抑制肠道内正常菌群,导致肠内菌群失调,阻碍维生素 K 吸收,从而可能引发出血^[6]。鉴于上述考虑,临床药师建议管床医生重点监测凝血功能,并对华法林用量进行调整,通过处理后置管处未见出血。

2.3 药物在药剂学方面的相互作用

如临床药师通过 PASS 系统监测发现某位患者其医嘱中存在 1 条警示信息,提示 0.9%氯化钠和多烯磷脂酰胆碱溶液存在配伍禁忌,通过查阅说明书发现多烯磷脂酰胆碱溶液不能使用林格氏液或氯化钠溶液等含有电解质溶液进行配制,临床药师与管床医生进行沟通后,将溶媒更改为 5%葡萄糖溶液。

虽然 PASS 系统可以简单、便捷、快速的发现医生医嘱中存在的药物相互作用,并及时作出相应的提示,但临床诊治的时候,影响治疗效果的因素有什么,选择适合的药物并不是一款软件可以决定,对患者进行治疗常常是权衡利弊的结果^[7]。在日常工作中由于药物作用性质、程度与患者年龄大小、用药时间和剂量及病情情况有关,所以 PASS 医嘱审核仅作为参考,临床药师需根据患者实际情况做出正确判断。

3 结语

临床药学在医院医疗服务工作中越来越重要,“患者为服务中心,合理使用药物为目标”已成为目前医院药学工作的核心内容,根据国家中医药管理局、总后卫生部、卫生部联合颁布的《医疗结构药事管理暂行规定》^[8]的相关规定,不断建立完善的临床药师工作机制。但由于目前临床药师工作还未形成完整的体系和系统,是临床药师工作得到很大的制约。因此临床药师在开展日常临床药物服务工作时应选取合理的切入点,同时深入临床一线,全程参与用药过程。临床诊治过程中,常需要实施多种不同作用的药物联合使用的情况,但由于已发的患者不良反应或药源性病症等已得到了广大医药专家的高度重视。临床药师在日常临床实践中可选取药物相互作用为切入点,掌握药物最新理论和信息、发挥药学专业特长,积极与临床医务人员交流和沟通,从而提高临床合理用药。

参考文献

- [1] 金慧.以药物不良反应为切入点开展临床药学服务[J].海峡药学,2012,24(9):274-275.
- [2] 王学彬,刘正跃,田泾等.“1+1”临床药师药学咨询服务模式在治疗药物监测中的应用[J].中国医院用药评价与分析,2012,12(11):1041-1044.
- [3] 李义秀,王永龙,章新晶.临床药师开展药物重整的药学服务实践[J].中国医院药学杂志,2016,36(12):1028-1031.
- [4] 韩勇,陈东生,张玉.临床药学实验室的药物个体化治疗药学服务内容与实践[J].中国医院药学杂志,2013,33(9):739-741.
- [5] 顾智淳,崔敏,刘晓琰等.基于药物相互作用软件提供的药学服务[J].药学服务与研究,2015,15(3):182-184.
- [6] 朱曼,孙艳.临床药师开展以药物相互作用为切入点的药学服务实践[J].中国药房,2009,20(11):877-878.
- [7] 胡婷婷,雍小兰.临床药师利用处方自动筛选系统对临床治疗药物监测的干预作用[J].中国新药杂志,2012,21(20):2450-2453.
- [8] 童志远,袁明勇,颜晓燕.基于《医疗机构药事管理规定》与《医疗机构药事管理暂行规定》的比较谈医院药学发展[J].中国医院药学杂志,2014,34(1):66-69.

(收稿日期:2017-08-25)